

КЛИНИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

Желудочно-кишечные кровотечения

Распознавание, оценка кровопотери и дифференциальный
диагноз на догоспитальном этапе

Верхние и нижние источники, клинически скрытое кровотечение, оценка объёма
кровопотери.

Состояния, имитирующие желудочно-кишечное кровотечение, и состояния, под которыми
оно протекает скрыто.

Серия «Крещение поворотом» · версия 1.1 · 16 августа 2026 · CC BY-NC-SA 4.0

Клинический случай

Вызов в здравпункт крупного предприятия, утро. Мужчина 41 года, рабочий, повод — головокружение. Со слов пациента, ночь не спал, с утра ничего не ел.

Объективно: сознание ясное, ориентирован. Лёгкий тремор пальцев рук. Обращают на себя внимание бледность кожи, синюшный оттенок склер и губ. Глюкоза крови 7,1 ммоль/л. АД **лёжа 130/80 мм рт. ст., сидя 90/70 мм рт. ст.** ЧСС лёжа 110 в минуту; в положении сидя и стоя частота не измерялась. В позе Ромберга устойчив, координаторные пробы без промахивания. ЭКГ без явных отклонений. Живот мягкий, безболезненный при пальпации во всех отделах, симптомов раздражения брюшины нет. На повторные вопросы о стуле отвечает, что утром был стул обычного цвета, изредка отмечает жёлтый стул, других особенностей нет; чёрного стула не было. Рвоты не было. Сочетание тремора и ортостатической гипотензии на фоне бессонной ночи и голодания было расценено как состояние после стресса с лёгкой дегидратацией; пациент оставлен на месте. Вечером того же дня он эвакуирован другой бригадой с продолжающимся кровотечением из нижних отделов желудочно-кишечного тракта: кровь на белье и на полу, при сохранном артериальном давлении.

Разбор случая приведён в конце материала.

Вопросы для размышления

Ответы — в конце материала.

1. Чем гиповолемическая ортостатическая гипотензия отличается от неврологической (автономной) и по какому показателю проводится разграничение?
2. Почему частота сердечных сокращений 110 в минуту в положении лёжа у пациента 41 года — клинический признак, а не фон?
3. О чём свидетельствуют бледность, синюшный оттенок склер и губ?
4. Что исключают и чего не исключают нормальная глюкоза крови и устойчивость в позе Ромберга?
5. Кому показано пальцевое ректальное исследование и почему указание пациента на нормальный стул его не заменяет?
6. Какие измерения остались невыполненными и как они повлияли бы на решение?

Общие положения

Желудочно-кишечное кровотечение (ЖКК) относится к числу состояний, при которых объём кровопотери на момент осмотра, как правило, недоступен прямой оценке: кровь депонируется в просвете желудочно-кишечного тракта, а её внешние проявления запаздывают по отношению к гемодинамическим. В части случаев кровотечение манифестирует не гематемезисом или меленой, а изолированными признаками гиповолемии — слабостью, головокружением, ортостатической гипотензией, синкопальным состоянием.

Летальность при ЖКК определяется преимущественно двумя обстоятельствами: недооценкой объёма кровопотери при формально сохраненных показателях гемодинамики и поздним распознаванием кровотечения при отсутствии явных внешних проявлений.

Материал включает:

- терминологию и клинические проявления кровотечения в зависимости от уровня источника;

- методы оценки объёма кровопотери и их ограничения;
- дифференциальный диагноз источников кровотечения;
- состояния, имитирующие ЖКК, и состояния, при которых оно остаётся нераспознанным;
- догоспитальную тактику и сведения о расхождениях между действующими протоколами и данными международных исследований.

Терминология и клинические проявления

Проявление	Характеристика	Уровень источника
Гематемезис	Рвота алой кровью, часто со сгустками	Верхний отдел; активное кровотечение
Рвота «кофейной гущей»	Тёмно-коричневое зернистое содержимое: гемоглобин, изменённый хлористоводородной кислотой до гематина	Верхний отдел; кровотечение состоявшееся или невысокой интенсивности
Мелена	Чёрный дегтеобразный неоформленный стул со специфическим запахом; результат бактериальной деградации гемоглобина	Верхний отдел, реже тонкая кишка
Гематокезия	Выделение алой или тёмной крови из прямой кишки	Нижний отдел; при массивном кровотечении — верхний отдел с ускоренным транзитом
Клинически скрытое кровотечение	Внешние проявления отсутствуют либо не отмечены пациентом; клиника представлена признаками анемии и гиповолемии	Любой уровень

Количественные ориентиры, определяющие клиническую картину:

- для появления мелены достаточно 50–100 мл крови, поступившей в верхние отделы; для формирования чёрного стула требуется время транзита, в среднем от 8 до 14 часов, в связи с чем при остром кровотечении мелена на момент осмотра может отсутствовать;
- мелена сохраняется в течение нескольких суток после остановки кровотечения и сама по себе не свидетельствует о его продолжении;
- гематокезия при верхнем источнике указывает на объём кровопотери, как правило, превышающий 1000 мл, и сопровождается нарушениями гемодинамики.



Внешние проявления желудочно-кишечного кровотечения: мелена — чёрный дегтеобразный неоформленный стул; гематемезис — рвота алой кровью; гематохезия — выделение крови из прямой кишки.

Топическая диагностика: верхний и нижний уровень

Разделение проводится по связке Трейца (дуоденоюнальный переход).

Признак	Верхнее ЖКК	Нижнее ЖКК
Частота	70–80 % случаев	20–30 % случаев
Основные проявления	Гематемезис, «кофейная гуща», мелена	Гематохезия, тёмная кровь с калом
Болевой синдром	Эпигастральная боль, анамнез диспепсии	Часто отсутствует; при ишемическом колите и ВЗК — боль предшествует
Соотношение мочевины/креатинин	Повышено (всасывание белков крови в тонкой кишке)	Не изменено
Аспират желудочного содержимого	Может содержать кровь	Не содержит крови

Отсутствие крови в желудочном содержимом не исключает верхнего источника: при кровотечении из постбульбарных отделов дуоденального отдела кровь может не поступать в желудок.



Расположение источников кровотечения относительно связки Трейца и соответствующие им клинические проявления: выше связки — гематемезис и мелена, ниже — мелена (тонкая кишка) и гематохезия. АВМ — артериовенозная мальформация, ВРВП — варикозно расширенные вены пищевода, ЯБ — язвенная болезнь.

Примечание к схеме: в первые часы кровотечения концентрация гемоглобина может оставаться нормальной, поскольку эритроциты и плазма теряются пропорционально, а гемодилюция развивается позднее; нормальный уровень гемоглобина не отражает объема кровопотери.

Оценка объема кровопотери

Шоковый индекс Алговера

Отношение частоты сердечных сокращений к систолическому артериальному давлению.

Индекс	Ориентировочный дефицит ОЦК	Клиническая трактовка
0,5–0,7	Отсутствует	Норма
~1,0	20–30 %	Шок I степени (компенсированный)
~1,5	30–50 %	Шок II степени
≥ 2,0	≥ 50 %	Шок III степени

Ограничения гемодинамической оценки

Нормальные показатели артериального давления не исключают значимой кровопотери. Основные причины несоответствия между объемом кровопотери и данными измерений:

- **Компенсаторная вазоконстрикция.** У пациентов молодого и среднего возраста артериальное давление удерживается за счёт периферического сопротивления и тахикардии вплоть до потери 30–40 % ОЦК; снижение давления соответствует срыву компенсации, а не началу кровотечения.
- **Артериальная гипертензия в анамнезе.** Давление 120/80 мм рт. ст. у пациента с привычными значениями 180/100 мм рт. ст. представляет собой относительную гипотензию.

- **Медикаментозная модификация ответа.** β -адреноблокаторы, ивабрадин, а также имплантированный электрокардиостимулятор препятствуют развитию компенсаторной тахикардии.
- **Возраст.** У пожилых компенсаторные возможности снижены, у пациентов с сердечной недостаточностью тахикардия может быть исходной.

Ортостатическая проба

Измерение артериального давления и частоты сердечных сокращений в положении лёжа и через 1–3 минуты после перехода в положение сидя или стоя. Значимым считается снижение систолического давления на 20 мм рт. ст. и более, диастолического — на 10 мм рт. ст. и более либо прирост частоты сердечных сокращений на 30 в минуту и более.

Проба позволяет выявить дефицит объёма при нормальных показателях в горизонтальном положении. Ортостатическая гипотензия, сопровождающаяся компенсаторной тахикардией, свидетельствует о гиповолемии; ортостатическая гипотензия без прироста частоты сердечных сокращений более характерна для автономной недостаточности и медикаментозного генеза. Проба не выполняется при исходной гипотензии, нарушении сознания и признаках шока.

Клинически скрытое кровотечение

Ситуация, при которой кровотечение не сопровождается замеченными пациентом внешними проявлениями. Наиболее характерна для медленного кровотечения из хронической язвы, эрозивных поражений на фоне приёма НПВС, ангиодисплазий и опухолей.

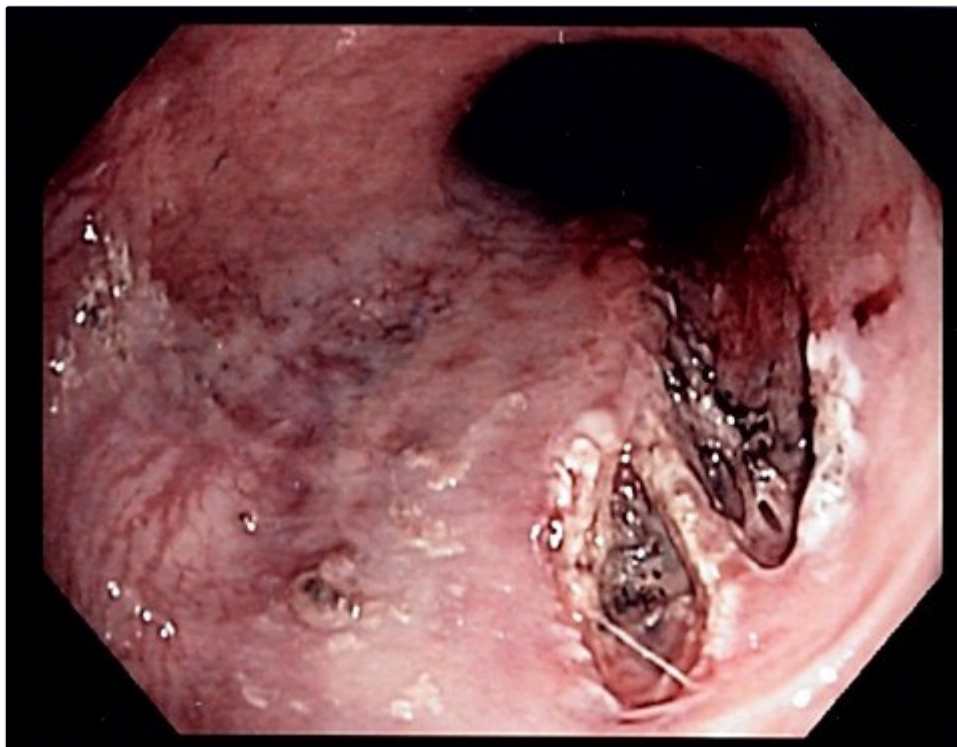
Клинические признаки, позволяющие заподозрить кровотечение при отсутствии гематемезиса и указаний на изменение стула:

- бледность кожи и слизистых, в том числе конъюнктив;
- слабость, снижение толерантности к нагрузке, головокружение при перемене положения тела, синкопальные состояния;
- тахикардия и ортостатическая гипотензия при нормальном давлении в покое;
- признаки периферической вазоконстрикции: холодные кожные покровы, замедленное капиллярное наполнение, акроцианоз;
- впервые возникшая или усилившаяся стенокардия, изменения на ЭКГ ишемического характера как следствие анемической гипоксии.

Пальцевое ректальное исследование с осмотром содержимого на перчатке позволяет выявить мелену либо следы крови и относится к обязательным элементам осмотра при подозрении на кровотечение, в том числе при отсутствии жалоб на изменение стула. Указание пациента на нормальный стул не заменяет исследования: изменение цвета кала нередко не замечается, а при отсутствии дефекации в течение предшествующих часов кровь может находиться в проксимальных отделах.

Дифференциальный диагноз источников

Верхние отделы	
Источник	Характерные особенности
Язвенная болезнь желудка и ДПК	Наиболее частая причина (около 40 %). Анамнез диспепсии, эпигастральная боль, связь с приёмом НПВС, инфекция <i>H. pylori</i>
Эрозивно-язвенные поражения (гастрит, дуоденит)	Приём НПВС, ацетилсалициловой кислоты, глюкокортикоидов, алкоголя; стрессовые поражения при критических состояниях. Кровотечение чаще диффузное, умеренной интенсивности
Варикозно расширенные вены пищевода и желудка	Портальная гипертензия при циррозе. Кровотечение массивное, часто алой кровью; сочетается с коагулопатией и тромбоцитопенией, что определяет тяжесть
Синдром Мэллори-Вейсса	Продольный разрыв слизистой кардиоэзофагеальной зоны после многократной рвоты или интенсивного кашля. Типична последовательность: рвота желудочным содержимым, затем рвота с алой кровью
Опухоли желудка и пищевода	Пожилой возраст, потеря массы тела, анорексия, длительная анемия; кровотечение чаще хроническое
Поражение Дъелафуа	Аномально крупная подслизистая артерия. Массивное кровотечение без предшествующих симптомов и без язвенного анамнеза
Аортоэнтеральная фистула	Состояние после протезирования аорты. Характерно «сигнальное» умеренное кровотечение, за которым следует профузное



Синдром Мэллори-Вейсса: продольный разрыв слизистой в кардиоэзофагеальной зоне, дефект покрыт фибрином, в дне определяется фиксированный сгусток.

Нижние отделы

Источник	Характерные особенности
Дивертикулёз	Наиболее частая причина у пожилых. Внезапная безболевого массивная гематохезия
Ангиодисплазии	Пожилым возрастом, хроническая болезнь почек, аортальный стеноз. Кровотечение рецидивирующее, нередко скрытое
Колоректальный рак	Хроническая анемия, изменение характера стула, потеря массы тела
Воспалительные заболевания кишечника	Кровь со слизью, диарея, боль, системные проявления
Ишемический колит	Пожилым возрастом, атеросклероз, фибрилляция предсердий, эпизод гипотензии; болевой синдром предшествует появлению крови
Геморроидальные узлы, анальная трещина	Алая кровь поверх кала, без нарушений гемодинамики. Диагноз правомерен только после исключения проксимальных источников
Постполипэктомическое кровотечение	Развивается в срок до 2 недель после эндоскопического вмешательства

Факторы, значимые для оценки риска

Приём НПВС, ацетилсалициловой кислоты, антикоагулянтов и антиагрегантов; хроническое употребление алкоголя; цирроз печени и портальная гипертензия; предшествующие кровотечения и эндоскопические вмешательства; онкологические

заболевания; хроническая болезнь почек; возраст старше 60 лет; сопутствующая кардиальная патология.

Признаки портальной гипертензии и хронического поражения печени, выявляемые при осмотре: телеангиэктазии, пальмарная эритема, гинекомастия, увеличение живота за счёт асцита, расширение подкожных вен передней брюшной стенки, иктеричность, следы расчёсов.

Состояния, имитирующие желудочно-кишечное кровотечение

Изменение окраски рвотных масс и стула без кровотечения

Состояние	Проявление	Дифференциальный признак
Препараты железа, висмута, активированный уголь	Чёрный стул	Стул оформленный, без характерного запаха мелены; проба на скрытую кровь отрицательна
Употребление свёклы, красящих напитков, рифампицин	Красная окраска стула или мочи	Отсутствие анемии и гемодинамических нарушений
Кровотечение из носоглотки, полости рта, после стоматологических вмешательств, тонзиллэктомии	Заглатывание крови с последующей рвотой и меленой	Выявление источника при осмотре ротоглотки и полости носа
Кровохарканье	Выделение алой пенистой крови	Связь с кашлем, а не с рвотой; лёгочный анамнез

Состояния, воспроизводящие клинику гиповолемии без кровотечения

Бледность в сочетании с ортостатической гипотензией и тахикардией не является специфичным признаком кровопотери и требует дифференциальной диагностики.

Механизм	Состояния	Дифференциальные признаки
Дегидратация	Рвота, диарея, недостаточное поступление жидкости, гипертермия, употребление алкоголя (подавление секреции АДГ этанолом с последующим диурезом)	Анамнез потерь, сухость слизистых, отсутствие анемии, отрицательное ректальное исследование
Осмотический диурез	Декомпенсация сахарного диабета, гипергликемические состояния	Гипергликемия, полиурия, кетоз
Минералокортикоидная недостаточность	Первичная надпочечниковая недостаточность	Гиперпигментация, гипонатриемия, потребность в соли
Медикаментозная вазодилатация	α-адреноблокаторы, нитраты, диуретики, антигипертензивные препараты, трициклические антидепрессанты, нейролептики	Связь с приёмом препарата, отсутствие тахикардии при автономной блокаде
Автономная недостаточность	Диабетическая нейропатия, паркинсонизм и мультисистемная атрофия, амилоидоз	Ортостатическая гипотензия без компенсаторной тахикардии
Снижение производительности сердца	Нарушения ритма и проводимости, инфаркт миокарда, тромбоэмболия лёгочной артерии, тампонада, аортальный стеноз	Данные ЭКГ, аускультативная картина, характер боли
Вазодилатация при системном воспалении	Сепсис, анафилаксия	Лихорадка либо очаг инфекции; уртикарии, ангиоотёк

Сочетание состояний

Наличие альтернативного объяснения гиповолемии не исключает кровотечения. Клинически значимо, что ряд факторов одновременно предрасполагает к дегидратации и к кровотечению: хроническое употребление алкоголя сопровождается как диуретическим эффектом этанола и рвотой, так и высокой вероятностью эрозивного гастрита, варикозного расширения вен пищевода, синдрома Мэллори–Вейсса, а также коагулопатии и тромбоцитопении при поражении печени. По этой причине выявление факторов дегидратации у такого пациента расширяет, а не сужает объём необходимого обследования; диагноз дегидратации устанавливается после исключения кровотечения.

Состояния, под которыми кровотечение протекает нераспознанным

- **Гастралгическая форма острого коронарного синдрома** — эпигастральная боль, слабость, гипотензия; требует регистрации ЭКГ. Возможно и обратное соотношение: анемия вследствие кровотечения провоцирует ишемию миокарда.

- **Расслоение аорты и разрыв аневризмы брюшной аорты** — боль и гиповолемия без наружного кровотечения.
- **Разрыв при внематочной беременности** у женщин репродуктивного возраста.
- **Инттоксикация и алкогольное опьянение** — маскируют изменения сознания, обусловленные гипоперфузией.

Догоспитальная тактика

Мероприятия при желудочно-кишечном кровотечении в соответствии с действующими алгоритмами оказания скорой медицинской помощи:

Мероприятие	Объём
Положение	Горизонтальное; транспортировка на носилках независимо от самочувствия пациента
Венозный доступ	Периферический катетер большого диаметра; при признаках шока — два доступа
Инфузионная терапия	Натрия хлорид 0,9 % 500 мл внутривенно капельно; при шоке — по протоколу геморрагического шока
Гемостатическая терапия	Транексамовая кислота 750 мг (15 мл) внутривенно
При кровотечении из варикозно расширенных вен пищевода (I85)	Дополнительно терлипрессин 1 мг (1 мл) внутривенно
Оксигенотерапия	При $SpO_2 \leq 93\%$
Инструментальный контроль	ЭКГ (дифференциальная диагностика с ОКС, оценка ишемии на фоне анемии), глюкометрия
Режим	Приём пищи и жидкости исключается
Тактика	Экстренная госпитализация в стационар с эндоскопической службой, с предварительным оповещением

Дополнительные положения:

- согревание пациента: гипотермия усугубляет коагулопатию;
- при неостановленном кровотечении инфузионная терапия проводится в объёме, обеспечивающем приемлемую перфузию, без стремления к нормализации артериального давления: избыточная инфузия сопровождается гемодилюцией, повышением давления в зоне повреждения и возобновлением кровотечения;
- нестероидные противовоспалительные препараты (в том числе кеторолак, метамизол) при продолжающемся кровотечении не применяются в связи с антиагрегантным действием и риском усиления кровотечения, а также с риском повреждения почек в условиях гипоперфузии;
- установка назогастрального зонда на догоспитальном этапе действующими алгоритмами не предусмотрена.

Расхождения между действующими протоколами и данными международных исследований

Вопрос	Действующий протокол	Международные данные
Транексамовая кислота при ЖКК	Транексамовая кислота 750 мг внутривенно предусмотрена алгоритмом	Исследование HALT-IT (2020; 12 009 пациентов) не выявило снижения летальности при ЖКК; отмечено увеличение частоты венозных тромбозов и судорожных приступов. Эффективность транексамовой кислоты доказана при травме (CRASH-2) и послеродовом кровотечении (WOMAN), но не при ЖКК
Целевые показатели гемодинамики	Инфузионная терапия кристаллоидами	Рестриктивная стратегия: при циррозе и варикозном кровотечении избыточное восполнение объема повышает портальное давление и риск рецидива (Villanueva, 2013)
Ингибиторы протонной помпы	На догоспитальном этапе не предусмотрены	Догоспитальное введение не влияет на летальность и потребность в гемостазе; оправдано в стационаре до эндоскопии
Терлипрессин	1 мг внутривенно при варикозном кровотечении	Соответствует международным рекомендациям (вазоактивная терапия до эндоскопии); учитывается риск ишемических осложнений и гипонатриемии

Признаки, определяющие экстренность

Признак	Клиническая интерпретация
Гематемезис алой кровью, гематохезия при верхнем источнике	Массивное продолжающееся кровотечение
Шоковый индекс $\geq 1,0$; систолическое давление < 90 мм рт. ст.	Кровопотеря 20–30 % ОЦК и более
Ортостатическая гипотензия при нормальных показателях в покое	Скрытый дефицит объёма
Признаки портальной гипертензии	Вероятность варикозного источника, массивного кровотечения и коагулопатии
Приём антикоагулянтов, антиагрегантов	Кровотечение, плохо поддающееся спонтанному гемостазу
Нарушение сознания, тахипноэ, олигурия	Декомпенсация, органная гипоперфузия
Ишемические изменения на ЭКГ	Анемическая гипоксия миокарда

Возвращение к клиническому случаю

Итог вызова и исход. Картина расценена как состояние после стресса с лёгкой дегидратацией на фоне бессонной ночи и голодания; пациент оставлен на рабочем месте. Вечером того же дня он эвакуирован другой бригадой с продолжающимся кровотечением из нижних отделов желудочно-кишечного тракта (кровь на белье и на полу) при сохранном артериальном давлении. Ретроспективно вызов представлял собой кровотечение на стадии, когда замеченных наружных проявлений ещё не было, а дефицит объёма уже формировал гемодинамическую картину.

Разграничение гиповолемической и неврологической ортостатической гипотензии. Ортостатическое снижение давления развивается при двух принципиально разных механизмах. При гиповолемии барорефлекс сохранён: уменьшение венозного возврата сопровождается компенсаторной тахикардией, поэтому падение давления сочетается с приростом частоты сердечных сокращений (ориентировочно на 30 в минуту и более при вертикализации). При автономной недостаточности и при медикаментозной симпатолитической блокаде барорефлекс не реализуется, и давление падает без адекватного прироста частоты. Разграничение проводится, таким образом, не по величине падения давления, а по реакции частоты сердечных сокращений на перемену положения. В данном вызове давление в ортостазе измерено, а частота в положении сидя и стоя — нет; именно это измерение отделяло бы гиповолемию от нейрогенной ортостатики.

Частота 110 в минуту в покое. Тахикардия в положении лёжа у пациента 41 года при отсутствии лихорадки, боли и явного психомоторного возбуждения — не фоновая величина, а признак, требующий объяснения. В сочетании с ортостатическим снижением давления она указывает на работающий с нагрузкой барорефлекс, то есть на гиповолемию, а не на автономную недостаточность.

Бледность, синюшные склеры и губы. Бледность кожи в сочетании с синюшным оттенком губ отражает снижение кислород-переносящей ёмкости крови и периферической перфузии. Синеватая окраска склер описана как признак, ассоциированный с железodefицитной анемией: истончённая склера пропускает подлежащую сосудистую оболочку. Совокупность этих находок смещает вероятность в сторону анемии, в том числе хронической кровопотери, и требует её исключения.

Что не исключают нормальный сахар и устойчивость в позе Ромберга. Глюкоза 7,1 ммоль/л — умеренная гипергликемия, объяснимая стрессовым выбросом катехоламинов; гипогликемическая природа головокружения ею исключается, природа гиповолемии — нет. Устойчивость в позе Ромберга и координаторные пробы без промахивания исключают мозжечковую и выраженную вестибулярную патологию как причину головокружения, но не имеют отношения к дефициту объёма: головокружение при гиповолемии носит пресинкопальный характер и провоцируется вертикализацией, а не расстройством координации.

Тремор. Мелкий тремор пальцев неспецифичен: он развивается как при алкогольной абстиненции, так и при адренергической активации, сопровождающей гиповолемию. Совпадение тремора с бессонной ночью и голоданием создаёт удобное, но не единственное объяснение; сам по себе тремор между этими причинами не различает.

Пальцевое ректальное исследование. При признаках дефицита объёма циркулирующей крови ректальное исследование с осмотром содержимого на перчатке относится к обязательным элементам осмотра, независимо от повода к вызову и от наличия жалоб на изменение стула. Указание пациента на нормальный стул его не заменяет: изменение цвета кала нередко не замечается, при отсутствии дефекации кровь может находиться в проксимальных отделах, а при кровотечении из нижних отделов первым проявлением бывает свежая кровь, ещё не отмеченная пациентом. В данном вызове это исследование замыкало бы дифференциальный ряд, к которому уже вели бледность, тахикардия и ортостатическая гипотензия.

Тактика, следующая из картины. Совокупность «бледность, синюшные склеры и губы, тахикардия в покое, ортостатическая гипотензия» составляет картину дефицита объёма и является показанием к горизонтальному положению, венозному доступу, ректальному исследованию и эвакуации на носилках в стационар независимо от субъективного самочувствия и способности пациента передвигаться. Мягкий безболезненный живот и отсутствие замеченной наружной крови значимого кровотечения не исключают.

Маршрут и передача. Стационар с круглосуточной эндоскопической службой, с предварительным оповещением. В передаче звучат: артериальное давление и частота сердечных сокращений в двух положениях, результат ректального исследования, признаки анемии при осмотре и объём проведённой терапии.

Резюме

- Объём кровопотери при ЖКК на догоспитальном этапе оценивается по показателям перфузии, а не по количеству видимой крови.
- Нормальное артериальное давление не исключает потери 30–40 % ОЦК у пациента молодого и среднего возраста; гипотензия соответствует срыву компенсации.
- Ортостатическая проба выявляет дефицит объёма при нормальных показателях в покое; сохранённый прирост частоты сердечных сокращений указывает на гиповолемическую природу.
- Пальцевое ректальное исследование относится к обязательным элементам осмотра при подозрении на кровотечение и не заменяется анамнестическими сведениями о характере стула.
- Мелена свидетельствует о состоявшемся кровотечении, но не о его продолжении; её отсутствие не исключает острого кровотечения.
- Наличие альтернативной причины гиповолемии, включая дегидратацию, не исключает кровотечения; при алкогольном анамнезе оба состояния закономерно сочетаются.

- Транспортировка осуществляется на носилках независимо от субъективного самочувствия пациента.
- Нестероидные противовоспалительные препараты при продолжающемся кровотечении не применяются.

Источники

- Алгоритмы оказания скорой медицинской помощи (Департамент здравоохранения города Москвы, 2025), раздел «Хирургические заболевания»; Приказ ДЗМ № 535.
- HALT-IT Trial Collaborators. Effects of a high-dose 24-h infusion of tranexamic acid on death and thromboembolic events in patients with acute gastrointestinal bleeding. *Lancet*, 2020.
- Villanueva C. et al. Transfusion strategies for acute upper gastrointestinal bleeding. *N Engl J Med*, 2013.
- Gralnek I. M. et al. Endoscopic diagnosis and management of nonvariceal upper gastrointestinal hemorrhage: ESGE Guideline, 2021.
- Oxford Handbook of Emergency Medicine — gastrointestinal bleeding, hypovolaemic shock.
- Tintinalli's Emergency Medicine: A Comprehensive Study Guide — upper and lower gastrointestinal bleeding.
- Верткин А. Л. Скорая медицинская помощь: руководство для фельдшеров и врачей.

Ответы на вопросы для размышления

1. При гиповолемии барорефлекс сохранён, и падение давления при вертикализации сопровождается компенсаторным приростом частоты сердечных сокращений (ориентировочно на 30 в минуту и более). При автономной недостаточности и медикаментозной симпатолитической блокаде давление падает без адекватного прироста частоты. Разграничение проводится по реакции частоты сердечных сокращений на перемену положения, а не по величине падения давления.
2. Тахикардия лёжа у пациента 41 года при отсутствии лихорадки, боли и возбуждения требует объяснения. В сочетании с ортостатическим снижением давления она указывает на работающий с нагрузкой барорефлекс, то есть на гиповолемию, а не на автономную недостаточность.
3. О снижении кислород-переносящей ёмкости крови и периферической перфузии. Синеватая окраска склер описана как признак, ассоциированный с железodefицитной анемией. Совокупность смещает вероятность в сторону анемии, включая хроническую кровопотерю.
4. Глюкоза 7,1 ммоль/л исключает гипогликемическую природу головокружения, но не природу гиповолемии. Устойчивость в позе Ромберга и координаторные пробы исключают мозжечковую и выраженную вестибулярную патологию, но не имеют отношения к дефициту объёма: головокружение при гиповолемии пресинкопальное и провоцируется вертикализацией.
5. Пальцевое ректальное исследование с осмотром содержимого на перчатке показано при признаках дефицита объёма циркулирующей крови независимо от повода к вызову и жалоб на стул. Слова пациента о нормальном стуле его не заменяют: изменение цвета кала нередко не замечается, при отсутствии дефекации кровь может находиться в проксимальных отделах, а при нижнем источнике первым проявлением бывает свежая, ещё не замеченная кровь.
6. Частота сердечных сокращений в положении сидя и стоя. Её прирост отделил бы гиповолемическую ортостатику от нейрогенной и, при сохранной картине (бледность, синюшные склеры, тахикардия в покое), склонил бы решение к горизонтальному

положению, ректальному исследованию и эвакуации на носилках вместо оставления на месте.

Источники иллюстраций

Файл	Что изображено	Источник и лицензия
melenahematemesishematochezia.png	Внешние проявления: мелена, гематемезис, гематоchezия	рисунок автора, CC BY-NC-SA 4.0
gi_bleeding_sources.png	Источники кровотечения относительно связки Трейца	рисунок автора, CC BY-NC-SA 4.0
malloryweiss.png	Синдром Мэллори-Вейсса, эндоскопическая схема	рисунок автора, CC BY-NC-SA 4.0

Выходные данные

Материал: «Желудочно-кишечные кровотечения». Версия 1.1 от 16 августа 2026.

Серия: «Крещение поворотом» — клинические разборы догоспитальной практики.

Лицензия: текст и оригинальные схемы — Creative Commons «С указанием авторства — Некоммерческая — С сохранением условий» 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0). Копировать, печатать и раздавать коллегам можно свободно, включая печать для подстанции; продавать — нельзя; при переработке сохраняется та же лицензия и указывается источник.

Оговорка. Материал учебный. Он не является нормативным документом, не заменяет действующие протоколы, клинические рекомендации и распоряжения службы и не может использоваться как единственное основание для клинического решения. Дозы, показания и маршрутизацию проверять по первоисточникам, действующим на момент чтения. Ответственность за решения у постели больного несёт медицинский работник, а не автор материала.

О клиническом случае. Случай рассказан от лица бригады и обезличен: нет имени, даты вызова, адреса, номера карты вызова и названия стационара, бытовые детали изменены. Совпадения с чужой практикой возможны и неизбежны: такие вызовы происходят ежедневно.

Нашли ошибку? Ошибка в дозе, сроке или механизме — не мелочь: материал читают перед сменой. Сообщить можно через раздел Issues репозитория проекта; исправление выходит новой версией, а изменение фиксируется в журнале изменений.